



INFORMACIÓN GENERAL		
Fecha de Impresión: 07/09/2026 15:29	Fecha de Atención: 06/04/2024 11:14	Impreso por: AMRANDA
Centro de atención: Z01 - Zaragoza	Admisión: AD941609	
Paciente: CC 932732 - VICTOR CENEN OSPINO CUETO		Sexo: M
Fecha de Nacimiento: 08/06/1938	Edad: 85 año(s), 9 mes(es) 29 día(s)	Estado Civil: Viudo
Religión:	Creencia:	
Régimen: 2 - Subsidiado	Nivel: 1	Carnet:
Dirección: URBANIZACION VIRGEN DEL CARMEN	Lugar: María la baja Bolívar	
Teléfono: 3126267357		
Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION		
Grupo Poblacional:	Raza:	Etnia:
Acompañante: LIBIA DEL ROSARIO OSPINO	Parentesco Acomp.:	
Teléfono Acomp.: 3023415631		
Dirección Acomp.:		
Responsable:	Parentesco Resp.: HIJA	
Teléfono Resp.:	Parentesco Resp.: HIJA	
Dirección Resp.:	Especialidad: MEDICINA INTERNA	
Médico Tratante: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ		Tipo Vinculación:
Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.		

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias
Fecha de Ingreso: 03/04/2024 04:11
Cama: CM897
Motivo de la Consulta:
"ESTA CON FIEBRE ALIO AYER DE ALTA POR FIEBRE,PATOLOGIA PULMONAR""

ANTECEDENTES:

9->

* 1-> TBC PULMONAR + ADENOCARCINOMA DE TIPO ACINAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO GLASON 3+4 GRUPO PRNOSTICO 2 EN TRATAMIENTO PALIATIVO.

* 2-> CATARATAS

* 5-> NIEGA ALERGIA MEDICAMENTO

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE MASCULINO DE 85 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE TBC PULMONAR HOSPITALIZADO EN UCI DADO DE ALTA AYER EN HORA DE LA TARDE RECONSULTA POR PRESENTA CUADRO CLINICO DE 6 HORAS CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES , EXACERBACION DE LA TOS MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA

PACIENTE MASCULINO EN LA NOVENA DÉCADA DE LA VIDA, CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE CADE PRÓSTATA EN TRATAMIENTO + HIPERTENSION ARTERIAL DE RECIÉN DIAGNÓSTICA + HOSPITALIZACIÓN PREVIO RECIENTE POR SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR IMAGENOLÓGIA Y CLÍNICA, SIN DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO INGRESA POR EXACERBACIÓN DE SÍNTOMAS (TOS). PACIENTE CON INDICACIÓN DE TERAPIA RIPE, YA INICIADA, CON BUENA TOLERANCIA. EN RONDA MÉDICA SE ENCUENTRA CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CON SIGNOS VITALES EN META, TOLERANDO OXÍGENO AMBIENTE. ESTAMOS A LA ESPERA REALIZACIÓN DE FIBROBRONCOSCOPIA, SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS QUE ESTA PUEDE SER REALIZADA DE FORMA AMBULATORIA DEBIDO A QUE PACIENTE SE ENCUENTRA ASINTOMÁTICO EN EL MOMENTO. SE LE EXPLICA CONDUCTA AL PACIENTE, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Revisión Por Sistema:

RESPIRATORIO

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

REGULAR ESTADO GENERAL

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCÉFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS , REACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HÚMEDA CUELLO MÓVL, NO DOLOROSO, NO ADENOPATÍA, NO INGURGITACIÓN YUGULAR.

Tórax:

EXPANSIBLE, NO TIRAJE INTERCOSTALES, PULMONES CLAROS HIPOVETILDADOS, CREPITOS GUESO , RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLO

Abdomen:

PERISTALSIS NORMAL, BLANDO, NO SE PALPA MASA, NO DOLOROSO, NO IRRITACIÓN PERITONEAL

Piel y faneras:

NO HERIDA, NO EQUIMOSIS, NO ULCERACIONES, SIN SIGNOS DE INFECCIÓN

Genito-Urinario:

GENITALES NO EXPLORADO PUÑO PERCUSIÓN BILATERAL NEGATIVO

Extremidades:

SIMÉTRICA, EUTRÓFICA, NO EDEMA, LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDO

Sistema nervioso central:

GLASGOW 15/15, FUERZA MUSCULAR 5/5, SENSIBILIDAD CONSERVADA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:27:20 p. m.

Admisión: AD941609

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: VICTOR CENEN OSPINO CUETO

EPICRISIS

Análisis:

SE TRATA DE PACIENTE MASCULINO DE 85 AÑOS DE EDAD REINGRESO HOSPITALIZADO EN UCUI DADO DE ALTA EL DIA DE AYER SE ENCUENTRA URGENCIA BAJO EL CONTEXTO DE SX FEBRIL + TBC PULMONAR + ADENOCARCINOMA DE TIPO ACINAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO GLASON 3+4 GRUPO PRONOSTICO 2 EN TRATAMIENTO PALIATIVO, ACTUALMENTE EN REGULAR ESTADO GENERAL, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SPO2 VARIABLE 90 -94% ,FEBRIL, CIFRAS TENSIONALES EN META AL EXAMEN FISICO PULMONAR CREPITS BILATERALES E HIPOVENTILACION SE INGRESA PARA MANEJO MEDICO, PARA CLINICOS, RX DE TORAX, VALORACION POR MEDICINA INTERNA

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal:

R509 : FIEBRE, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1:

J189 : NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

EVOLUCIONES:

Fecha: 03/04/2024: 09:43:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Tuberculosis pulmonar probable por imagenología y clínica, sin diagnóstico microbiológico
2. Neumonía adquirida en la comunidad tratada (Marzo 26-Abril 02)
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Falla renal aguda KDIGO I

Antecedentes

1. Hipertensión arterial de reciente diagnóstico
2. Adenocarcinoma de próstata tipo acinar moderadamente diferenciado Gleason 3+4 funcional.

Subjetivo:

Refiere pasar regular noche, quebrantamiento general, sensación de alzas terminas no cuantificadas en casa, niega cefalea, diarrea u otra sintomatología asociada.

Objetivo:

Signos vitales: PA 105/78 mmHg, FC 115 lpm, FR 15 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en regular estado general, buen estado musculoesquelético,

Piel normocrómica, sin lesiones.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes asimétricos, llenado capilar 2 segundos.

Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLINICOS:

03/04/2024

Hemograma: Leucocitos 12,62, Neutrófilos 86,7% 10,95#, Linfocitos 6,6% 0,84#, Eosinófilos 0,13% 0,00#, Eritrocitos 3.52 millones, Hemoglobina 8,5, Hematocrito 27,3%, VCM 77,4, HCM 24.1, ADE 14,0, Plaquetas 202.000

bun: 43 creatinina: 1.52 por: 13.8

Fecha: 03/04/2024

Gases arteriales: pH: 7.521, pCO2: 32.5, pO2: 72.8, BE: 3.2, HCO3-std: 27.3, PaO2/FIO2: 3.47, AnGap: 18.2

Análisis:

Se trata de paciente masculino en la novena década de la vida con antecedente patológico de CA de próstata en tratamiento quien estuvo internado hasta el día de ayer en contexto de sospecha de tuberculosis pulmonar y sepsis de origen pulmonar en resolución actualmente reconsulta en el marco de reaparición de la sintomatología que motivó su primer ingreso, le habían egresado con orden de fibrobroncoscopia ambulatoria dado que no se logró rescate microbiológico pero contanto don imágenes sugestivas con orden de terapia RHZE ambulatoria.

Tiene laboratorios con mínima leucocitosis y neutrofilia, anemia moderada de volúmenes bajos, recuento plaquetario normal. Azoados elevados, PCR elevada. gases arteriales con alcalosis mixta y buenos índices de oxigenación.

Este paciente no tiene diagnóstico microbiológico de tuberculosis y es necesario obtenerlo, se fue de alta ayer en el día y ante persistencia de síntomas (Tos y disnea) regresa por la madrugada. Cuenta con rx de torax en el cual se observa notable mejoría con respecto a las anteriores, con persistencia de los hallazgos que sugieren infección granulomatosa, sin imágenes sugestivas de sobreinfección bacteriana adicional. Debe hacerse la logística de diagnóstico de forma hospitalaria, considero que es necesaria la realización de fibrobroncoscopia. Se indica hidratación endovenosa para manejo de falla renal aguda y solicito laboratorios para esclarecer etiología de la anemia. Dejo a discreción de infectología la decisión del inicio empírico de terapia RIPE. Se explica al paciente y a sus familiares la conducta a seguir.

Fecha: 04/04/2024: 14:29:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR PROBABLE POR IMAGENOLÓGIA Y CLÍNICA, SIN DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO
2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD TRATADA (MARZO 26-ABRIL 02)
3. ANEMIA MODERADA MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA
4. FALLA RENAL AGUDA KDIGO I

ANTECEDENTES

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE RECIENTE DIAGNÓSTICO
2. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA TIPO ACINAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO GLEASON 3+4 FUNCIONAL.

PACIENTE REFIERE REGULAR NOCHE, CON LEVE MEJORÍA DEL CUADRO CLÍNICO. NIEGA LA PRESENCIA DE CEFALÉA, NÁUSEA, DIARREA Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE REGULAR NOCHE, CON LEVE MEJORÍA DEL CUADRO CLÍNICO. NIEGA LA PRESENCIA DE CEFALÉA, NÁUSEA, DIARREA Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

Signos vitales: PA 136/71 mmHg, FC 85 lpm, FR 19 rpm, T 36.0°C, SpO2 99% a aire ambiente Luce en regular estado general, buen estado musculoesquelético, Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:27:20 p. m.

Admisión: AD941609

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: VICTOR CENEN OSPINO CUETO

EPICRISIS

facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes asimétricos, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

PARACLÍNICOS:

03/04/2024 Hemograma: Leucocitos 12.62, Neutrófilos 86,7% 10,95#, Linfocitos 6,6% 0.84#, Eosinófilos 0,13% 0.00#, Eritrocitos 3.52 millones, Hemoglobina 8,5, Hematocrito 27,3%, VCM 77.4, HCM 24.1, ADE 14,0, Plaquetas 202.000 bun:43 creatinina:1.52 pcr:13.8 Fecha:03/04/2024 Gases arteriales: pH:7.521, pCO2: 32.5, pO2:72.8, BE:3.2, HCO3-std:27.3, PaO2/FiO2:3.47, AnGap:18.2

Ingreso previo

30/03/2024 TP 10.6 CONTROL 11 INR 1.1, TTP 33.6 CONTROL 29.9, LEU 14.72, NEU 91.8% 13.51, LINF 4.1% 0.61, HB 9.4, HTO 29.7, VCM78.7, HCM24.9, PLT 282, BUN 18, CL 104, CREAT 1.33, K 3.9, MG 2.2, NA 141, PCR 18.2

29/03/2024 HIV 1 Y 2 Negativo, CL 100, K 3.8, MG 1.6, na 136

27/03/2024

leu 19.02, neu 92.1% 17.51, linf 3.6% 0.69, hb 10.3, hto 32%, vcm 77.6, hcm 25.1, plt 248, bun 18, bt 0.66, bd 0.27, bi 0.39, ca 1.07, cl 101, creat 0.92, k 3.9, mg 1.6, na 137, pcr 24.9

IMÁGENES

03/04/2024

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX:

Silueta cardiaca aumentada de tamaño.

Tráquea centrada. Leve prominencia del botón aórtico.

Acentuación de los hilios pulmonares.

Radiopacidades hacia el lóbulo superior derecho y el espacio retrocardiaco con broncograma aéreo sugiriendo proceso neumónico. Correlacionar con su historia clínica. Los senos costofrénicos se observan libres.

Cambios degenerativos de la columna dorsal.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA NOVENA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE CA DE PRÓSTATA EN TRATAMIENTO + HIPERTENSION ARTERIAL DE RECIÉN DIAGNÓSTICA + HOSPITALIZACIÓN PREVO RECIENTE POR SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR CON INDICACIÓN DE TERAPIA RIPE Y REALIZACIÓN AMBULATORIA DE FIBROBRONCOSCOPIA, SIN EMBARGO, INGRESA POR PERSISTENCIA DE SÍNTOMAS. PACIENTE EN LA RONDA MÉDICA DEL DÍA DE HOY SE ENCUENTRA CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CON SIGNOS VITALES EN META, TOLERANDO OXÍGENO AMBIENTE. ESTAMOS A LA ESPERA REALIZACIÓN DE FIBROBRONCOSCOPIA CONTINÚA BAJO TERAPIA RIPE. SE LE EXPLICA CONDUCTA AL PACIENTE, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 05/04/2024: 12:46:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PROBLEMA

1. TUBERCULOSIS PULMONAR PROBABLE POR IMAGENOLÓGICA Y CLÍNICA, SIN DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO
2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD TRATADA (MARZO 26-ABRIL 02)
3. ANEMIA MODERADA MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA
4. FALLA RENAL AGUDA KDIGO I

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE RECIÉN DIAGNÓSTICO
2. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA TIPO ACINAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO GLEASON 3+4 FUNCIONAL.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE BUENA NOCHE, CON MEJORÍA DEL CUADRO CLÍNICO. NIEGA LA PRESENCIA DE CEFALÉA, NÁUSEA, DIARREA Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

Signos vitales: PA 140/80 mmHg, FC 87 lpm, FR 19 rpm, T 36.3°C, SpO2 99% a aire ambiente Luce en regular estado general, buen estado musculoesquelético, Piel normocrómica, sin lesiones. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes asimétricos, llenado capilar 2 segundos. Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en las 4 extremidades, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha normal.

03/04/2024 Hemograma: Leucocitos 12.62, Neutrófilos 86,7% 10,95#, Linfocitos 6,6% 0.84#, Eosinófilos 0,13% 0.00#, Eritrocitos 3.52 millones, Hemoglobina 8,5, Hematocrito 27,3%, VCM 77.4, HCM 24.1, ADE 14,0, Plaquetas 202.000 bun:43 creatinina:1.52 pcr:13.8 Fecha:03/04/2024 Gases arteriales: pH:7.521, pCO2: 32.5, pO2:72.8, BE:3.2, HCO3-std:27.3, PaO2/FiO2:3.47, AnGap:18.2

Ingreso previo

30/03/2024 TP 10.6 CONTROL 11 INR 1.1, TTP 33.6 CONTROL 29.9, LEU 14.72, NEU 91.8% 13.51, LINF 4.1% 0.61, HB 9.4, HTO 29.7, VCM78.7, HCM24.9, PLT 282, BUN 18, CL 104, CREAT 1.33, K 3.9, MG 2.2, NA 141, PCR 18.2

29/03/2024 HIV 1 Y 2 Negativo, CL 100, K 3.8, MG 1.6, na 136

27/03/2024

leu 19.02, neu 92.1% 17.51, linf 3.6% 0.69, hb 10.3, hto 32%, vcm 77.6, hcm 25.1, plt 248, bun 18, bt 0.66, bd 0.27, bi 0.39, ca 1.07, cl 101, creat 0.92, k 3.9, mg 1.6, na 137, pcr 24.9

IMÁGENES

03/04/2024

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:27:20 p. m.

Admisión: AD941609

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: VICTOR CENEN OSPINO CUETO

EPICRISIS

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX:

Silueta cardiaca aumentada de tamaño.

Tráquea centrada. Leve prominencia del botón aórtico.

Acentuación de los hilios pulmonares.

Radiopacidades hacia el lóbulo superior derecho y el espacio retrocardíaco con broncograma aéreo sugiriendo proceso neumónico. Correlacionar con su historia clínica. Los senos costofrénicos se observan libres.

Cambios degenerativos de la columna dorsal.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA NOVENA DÉCADA DE LA VIDA, CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE CA DE PRÓSTATA EN TRATAMIENTO + HIPERTENSION ARTERIAL DE RECIÉN DIAGNÓSTICA + HOSPITALIZACIÓN PREVIO RECIENTE POR SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR IMAGENOLOGÍA Y CLÍNICA, SIN DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO INGRESA POR EXACERBACIÓN DE SÍNTOMAS. PACIENTE CON INDICACIÓN DE TERAPIA RIPE, INICIADA EL DÍA DE HOY. EN RONDA MÉDICA SE ENCUENTRA CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CON SIGNOS VITALES EN META, TOLERANDO OXÍGENO AMBIENTE. ESTAMOS A LA ESPERA REALIZACIÓN DE FIBROBRONCOSCOPIA CONTINÚA BAJO TERAPIA RIPE. SE LE EXPLICA CONDUCTA AL PACIENTE, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 06/04/2024: 11:11:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PROBLEMA 1. TUBERCULOSIS PULMONAR PROBABLE POR IMAGENOLOGÍA Y CLÍNICA, SIN DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD TRATADA (MARZO 26-ABRIL 02) 3. ANEMIA MODERADA MICROCÍTICA HIPOCRÓMICA 4. FALLA RENAL AGUDA KDIGO I 1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE RECIÉN DIAGNÓSTICO 2. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA TIPO ACINAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO GLEASON 3+4 FUNCIONAL.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE BUENA NOCHE, CON MEJORÍA DEL CUADRO CLÍNICO. NIEGA LA PRESENCIA DE CEFALEA, NÁUSEA, DIARREA Y OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA.

Objetivo:

LUCE EN BUEN ESTADO GENERAL, BUEN ESTADO MUSCULOESQUELÉTICO, PIEL NORMOCRÓMICA SIN LESIONES. CUERO CABELLUDO NORMOIMPLANTADO, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, ISOCORIA NORMORREACTIVA, OCULOMOTORES NORMALES, SIMETRÍA FACIAL, FOSAS NASALES PERMEABLES, MUCOSA ORAL HÚMEDA, OROFARINGE NORMAL CUELLO SIMÉTRICO, SIN INGURGITACIÓN YUGULAR, SIN SOPLOS CAROTÍDEOS, MÓVL, SIN MASAS NI ADENOPATÍAS PALPABLES. TÓRAX SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, NO TIRAJES, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL PRESENTE, SIN SOBREGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS ABDOMEN PLANO, PERISTALSIS (+), BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL NI PROFUNDA, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, SIN MASAS NI MEGALIAS PALPABLES. EXTREMIIDADES SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, SIN EDEMA, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES ASIMÉTRICOS, LLENADO CAPILAR 2 SEGUNDOS. GLASGOW COMA SCALE 15/15 (O4, V5, M6), CONSCIENTE, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, SENSIBILIDAD CONSERVADA, LENGUAJE FLUIDO, NÓMINA Y REPITE, PARES CRANEALES SIN DÉFICIT, FUERZA MUSCULAR 5/5 EN LAS 4 EXTREMIIDADES, NORMORREFLÉXICO, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, MARCHA NORMAL.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA NOVENA DÉCADA DE LA VIDA, CON ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE CA DE PRÓSTATA EN TRATAMIENTO + HIPERTENSION ARTERIAL DE RECIÉN DIAGNÓSTICA + HOSPITALIZACIÓN PREVIO RECIENTE POR SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR POR IMAGENOLOGÍA Y CLÍNICA, SIN DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO INGRESA POR EXACERBACIÓN DE SÍNTOMAS (TOS). PACIENTE CON INDICACIÓN DE TERAPIA RIPE, YA INICIADA, CON BUENA TOLERANCIA EN RONDA MÉDICA SE ENCUENTRA CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CON SIGNOS VITALES EN META, TOLERANDO OXÍGENO AMBIENTE. ESTAMOS A LA ESPERA REALIZACIÓN DE FIBROBRONCOSCOPIA, SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS QUE ESTA PUEDE SER REALIZADA DE FORMA AMBULATORIA DEBIDO A QUE PACIENTE SE ENCUENTRA ASINTOMÁTICO EN EL MOMENTO. SE LE EXPLICA CONDUCTA AL PACIENTE, QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Fecha: 03/04/2024

-332203 - BRONCOSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR- Cantidad: 1

-871121 - RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL CON BARIO) - Cantidad: 2

-901111 - BACILOSCOPIA COLORADA ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS - Cantidad: 1

-901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO - Cantidad: 1

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903016 - FERRITINA - Cantidad: 1

-903044 - SATURACIÓN DE TRANSFERRINA - Cantidad: 1

-903603 - CALCIO AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 2

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 2

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 2

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-906333 - Aspergillus spp ANTIGENO [GALACTOMANAN] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-906913 - PROTEÍNA C REACTIVA ALTA PRECISIÓN AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

Fecha: 04/04/2024

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 06/04/2024

-332203 - BRONCOSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR- Cantidad: 1

-890306 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA - Cantidad: 1

-890354 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGÍA - Cantidad: 1

-890366 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA - Cantidad: 1

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Fecha: 03/04/2024

-0001 - Solución Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:27:20 p. m.

Admisión: AD941609

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: VICTOR CENEN OSPINO CUETO

EPICRISIS

-0002 - Solucion Salina Normal 250 ML SSN - Cantidad: 2
 -0004 - DEXTROSAAL 5% EN AGUA DESTILADADAD - Cantidad: 3
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR - Cantidad: 4
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 10
 -10042 - Norepinefrina Bitartato - Cantidad: 5
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR - Cantidad: 1
 -9867 - Cefepime - Cantidad: 6
 -9881 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C08CA03701 - Amlodipino - Cantidad: 1
 -CCCEXPANE - Extension de Anestesia - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 2
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -J01XV013721 - Vancomicina clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 2
 -R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG - Cantidad: 1

Fecha: 04/04/2024

-0002 - Solucion Salina Normal 250 ML SSN- Cantidad: 4
 -0004 - DEXTROSAAL 5% EN AGUA DESTILADADAD - Cantidad: 3
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR - Cantidad: 13
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 15
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 10
 -9867 - Cefepime - Cantidad: 18
 -9881 - Omeprazol - Cantidad: 3
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -Ag16 - Aguja Hipodermica # 16 - Cantidad: 3
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 3
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 4
 -HUCDES166 - JERINGA DE INSULINA 1 ML - ITEM(169) - Cantidad: 4
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 8
 -IM7541 - SET ALIMENTACIÓN DOBLE BOLSA PARA ALIMENTACIÓN E IRRACIONABLE - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 6
 -J01XV013721 - Vancomicina clorhidrato - Cantidad: 8

Fecha: 05/04/2024

-0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 4
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 10
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 9
 -9867 - Cefepime - Cantidad: 12
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 4
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C08CA03701 - Amlodipino - Cantidad: 2
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 2
 -HUCDES66 - ELECTRODO MONITOREO ADULTO REF 2223 - VALLEYLAB - ITEM(68) - Cantidad: 5
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 5
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 1

Fecha: 06/04/2024

-9943 - Amlodipino - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCDES166 - JERINGA DE INSULINA 1 ML - ITEM(169) - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 6

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha: 03/04/2024

Indicaciones:

- Hospitalizar en sala de infectologia o habitacion aislado
- O2 por canula nasal 3 lt/min solo si saturacion inferior a 92%
- Lactato de ringer a 50 cc/hora**Nuevo**
- Amlodipino 5 mg via oral cada 24 horas
- Acetaminofen 500 mg dar 2 tabletas cada 8 horas si temperatura superior a 38 grados
- SS/ Ferritina, Saturacion de transferrina, sodio, potasio, cloro, magnesio
- Se solicita: Fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar y biopsia
- Se solicita en Lavado broncoalveolar: Prueba molecular para Mtuberculosis, Baciloscopia,

- Registrar signos vitales y avisar cambios

Fecha: 03/04/2024

Indicaciones:

- Hospitalizar en sala de infectologia o habitacion aislado

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:27:20 p. m.

Admisión: AD941609

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: VICTOR CENEN OSPINO CUETO

EPICRISIS

- O2 por canula nasal 3 lt/min solo si saturacion inferior a 92%
- Lactato de ringer a 50 cc/hora**Nuevo**
- Amlodipino 5 mg via oral cada 24 horas
- TERAPIA RHZE 150/75/400/275mg tabletas uso: 4 tabletas via oral cada día por 56 dosis en total**Diferir hasta evaluación por infectología**
- Acetaminofen 500 mg dar 2 tabletas cada 8 horas si temperatura superior a 38 grados
- SS/ Ferritina, Saturacion de transferrina, sodio, potasio, cloro, magnesio
- Se solicita: Fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar y biopsia
- Se solicita en Lavado broncoalveolar: Prueba molecular para Mtuberculosis, Baciloscopia, Galactomanano
- Registrar signos vitales y avisar cambios

Fecha: 03/04/2024

Indicaciones:

Hospitalizar en sala de observación

- O2 por canula nasal 3lt/min solo si saturacion inferior a 92%
- Tapon venoso
- SSN 0,9% 500cc iv a razon de 30cc
- amlodipino 5mg via oral cada 24horas
- TERAPIA RHZE 150/75/400/275mg tabletas uso: 4 tabletas via oral cada día por 56 dosis en total (aun no inicia)
- Acetaminofen 500mg dar 2 tabletas cada 8 horas si temperatura superior a 38 grados
- SS Electrocardiograma de 12 derivaciones, RX de torax, Gasometría arterial
- Pendiente Hemograma, PCR, bun, creatinina, ionograma.
- Registrar signos vitales y avisar cambios

Fecha: 03/04/2024

Indicaciones:

- OBSERVACION
- N95 PERMEMENTE
- OXIGENO CANULA NASAL PASAR A 3 LT/MINUTOS
- PARACETAMOL 1 GR IV
- SALBUTAMOL 6 PUFF CADA 20 MINUTOS POR 1 HORA CONTINUAR CADA 1 HORA POR 3 HORAS
- BROMURO DE IPATROPIOS 6 PUFF CADA 20 MINUTOS POR 1 HORA CONTINUAR CADA 1 HORA POR 3 HORAS
- S/S HEMOGRAMA, PCR, FUNCION RENAL, RX DE TORAX
- S/S VALORACION POR MEDICINA INTERNA
- CSV-AC

Fecha: 04/04/2024

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN HAB UNIPERSONAL
- ASLAMIENTO RESPIRATORIO
- USO DE MASCARILLA N95 PERMANENTE
- O2 POR CANULA NASAL 3LT/MIN SOLO SI SATURACION INFERIOR A 92%
- SS 0,9% 500 CC IV, PASAR A RAZÓN DE 30 CC/HR
- TAPON VENOSO

TERAPIA RHZE 150/75/400/275MG TABLETAS USO: 4 TABLETAS VIA ORAL CADA DÍA POR 56 DOSIS EN TOTAL
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 HORAS
 AMLODIPINO TAB 5 MG VIA ORAL CADA 24 HORAS
 ACETAMINOFÉN TAB 500 MG, DAR 2 TABLETAS VO CADA 8 HORAS

REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

S/S AZOADOS CONTROL FS. 04/04/24

PENDIENTE:

P/ FIBROBRONCOSCOPIA + LAVADO BRONCOALVEOLAR FS. 03/04/24

Fecha: 05/04/2024

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN HAB UNIPERSONAL
- SE ACTIVA REMISIÓN EXTERNA A CENTRO DE SALUD QUE CUENTE CON FIBROBRONCOSCOPIA
- ASLAMIENTO RESPIRATORIO
- USO DE MASCARILLA N95 PERMANENTE
- O2 POR CANULA NASAL 3LT/MIN SOLO SI SATURACION INFERIOR A 92%
- TAPON VENOSO

TERAPIA RHZE 150/75/400/275MG TABLETAS USO: 4 TABLETAS VIA ORAL CADA DÍA POR 56 DOSIS EN TOTAL
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 HORAS
 AMLODIPINO TAB 5 MG VIA ORAL CADA 24 HORAS
 ACETAMINOFÉN TAB 500 MG, DAR 2 TABLETAS VO CADA 8 HORAS

REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTE:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:27:20 p. m.

Admisión: AD941609

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: VICTOR CENEN OSPINO CUETO

EPICRISIS

P/ FIBROBRONCOSCOPIA + LAVADO BRONCOALVEOLAR FS. 03/04/24

Fecha: 06/04/2024

Indicaciones:

FÓRMULA MÉDICA:

TERAPIA RHZE TABLETAS 150/75/400/275 MG, USO: TOMAR 4 TABLETAS VIA ORAL CADA DÍA POR 56 DOSIS EN TOTAL
PIRIDOXINA TABLETAS 50 MG, USO: TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 24 HORAS POR 30 DÍAS #30
AMLODIPINO TABLETAS 5 MG, USO: TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 24 HORAS POR 30 DÍAS #30

Fecha: 06/04/2024

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN HAB UNIPERSONAL

SE ACTIVA REMISIÓN EXTERNA A CENTRO DE SALUD QUE CUENTE CON FIBROBRONCOSCOPIA

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

USO DE MASCARILLA N95 PERMANENTE

O2 POR CANULA NASAL 3LT/MIN SOLO SI SATURACION INFERIOR A 92%

TAPON VENOSO

TERAPIA RHZE 150/75/400/275MG TABLETAS USO: 4 TABLETAS VIA ORAL CADA DÍA POR 56 DOSIS EN TOTAL
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 HORAS
AMLODIPINO TAB 5 MG VIA ORAL CADA 24 HORAS
ACETAMINOFÉN TAB 500 MG, DAR 2 TABLETAS VO CADA 8 HORAS

REGISTRAR SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTE:

P/ FIBROBRONCOSCOPIA + LAVADO BRONCOALVEOLAR FS. 03/04/24

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

EGRESO MÉDICO.

Complicaciones:

NINGUNO.

Servicio de Egreso: 000033|Hospitalización Gral 10mo Piso

Fecha de Egreso: 06/04/2024 11:14

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A161 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, SIN EXAMEN BACTERIOLOGICO E HISTOLOGICO

Diagnóstico Relacionado 1: I10X : HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR
MEDICINA:

Tratamiento Farmacológico:

FÓRMULA MÉDICA:

TERAPIA RHZE TABLETAS 150/75/400/275 MG, USO: TOMAR 4 TABLETAS VIA ORAL CADA DÍA POR 56 DOSIS EN TOTAL
PIRIDOXINA TABLETAS 50 MG, USO: TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 24 HORAS POR 30 DÍAS #30
AMLODIPINO TABLETAS 5 MG, USO: TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 24 HORAS POR 30 DÍAS #30

REALIZAR DE FORMA AMBULATORIA BRONCOSCOPIA + LAVADO BRONCOALVEOLAR.

CITA PRIORITARIA POR MEDICINA INTERNA POR SU EPS.

CITA PRIORITARIA POR INFECTOLOGÍA POR SU EPS.

CITA PRIORITARIA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA POR SU EPS.

Recomendaciones Adicionales:

SE DAN VERBALMENTE.

Aplica Cuidados de Enfermería: No



YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ
MEDICINA INTERNA
CC.45548454 - RM.16138